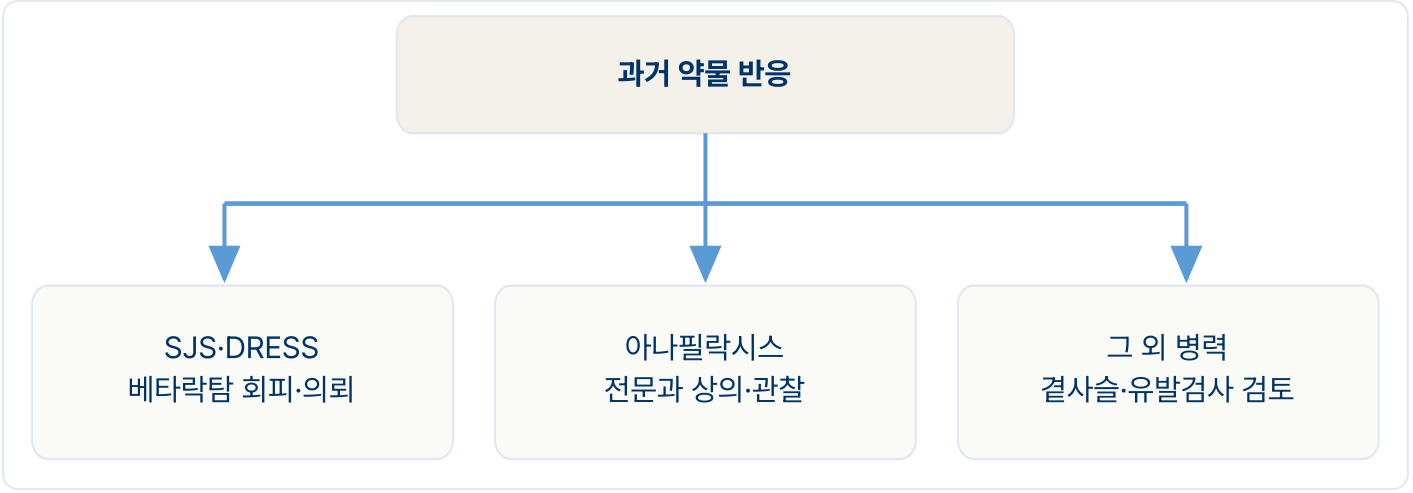
항생제 알레르기 병력 부비동염 처방 전에 묻기

알레르기 꼬리표·반응 양상·항생제 필요성을 함께 판단



권혁수 연자 Q&A · 병력 4문항

① 반응이 5년 이내인가? ② 아나필락시스·혈관부종인가? ③ 피부 박리·점막 침범 중증 피부반응인가? ④ 응급실 방문·치료가 필요했나? 모두 아니면 낮은 위험 병력으로 알레르기내과 경구유발검사를 통해 꼬리표 제거를 검토합니다.

! 중증 피부반응

SJS 또는 DRESS 병력은 모든 베타락탐을 피하고 의뢰합니다. 아나필락시스 병력은 첫 복용을 병원에서 시행하고 약 30분 관찰하거나 알레르기내과와 상의한다는 연자 Q&A입니다.

비아나필락시스성 페니실린 병력

연자 Q&A: 곁사슬이 다른 세팔로스포린을 고려합니다. 교차반응 전체는 약 1~2%이며 베타락탐 고리보다 곁사슬 유사성이 중요합니다. 기록상 페니실린 알레르기의 >90%는 실제 알레르기가 아니라고 설명했습니다.

곁사슬과 대체 약제

아래 선택·용법은 권혁수 연자 Q&A의 설명

amoxicillin·ampicillin 병력

amoxicillin과 유사해 피할 약: cefadroxil, cefprozil, cefaclor. Ampicillin과 유사해 피할 약: cephalexin, cefaclor. 곁사슬이 다른 약으로 cefuroxime, cefpodoxime, cefdinir, cefditoren, ceftriaxone을 소개했습니다. 중증 피부반응 분기는 별도로 적용합니다.

두 계열 모두 진짜 알레르기

Levofloxacin 500 mg 하루 1회 5~7일 또는 moxifloxacin 400 mg 하루 1회 5~7일을 대안으로 소개했습니다. 건염·건파열, QT 연장, 혈당 이상, 말초신경병증, 대동맥류·박리 위험을 고려해 꼭 필요할 때만 사용합니다.

항생제 필요성부터 판단

10일 이상 무호전, 호전 뒤 5~6일째 이중악화, 고열 >39°C+농성콧물+안면통 3~4일 중 하나에서 세균성을 의심합니다. 누런 콧물만으로 세균성이라 보지 않습니다. 합병증 없는 경우 경과관찰·세척·INCS·진통제를 사용하고 3~5일 더 보아 악화/무호전이면 항생제 시작을 설명합니다.

강의의 경험적 항생제 선택

Amoxicillin/clavulanate가 기본이며 보통 5~7일입니다. Macrolide·TMP/SMX·cefaclor·doxycycline의 경험적 사용은 한국 내성 때문에 부적절하다고 설명했습니다. 치료 3~5일 무호전이면 진단·복약·치성 원인·합병증을 재평가하고 변경/의뢰합니다.